กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

แนวทางการดำเนินงาน
ให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2570





กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2570

ที่ปรึกษา

นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร	ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

คณะทำงานจัดทำแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ	คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร	ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย	ผู้อำนวยการฝ่ายไทย ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
นายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ชาตรี จุลเพชร	กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงศุภรัตน์ เข็มนาค	สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
เภสัชกรอภิชัย พจน์เลิศอรุณ	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงปิยดา อังศุวัชรากร	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นางสาวปิยะภรณ์ โพธิ์คำ	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นางสาวธนพร ธำรงลักษ์	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คณะผู้เรียบเรียง

นายแพทย์ธนพล ยิสารคุณ	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นางสาวธนพร ธำรงลักษ์	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นางสาวปิยะภรณ์ โพธิ์คำ	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คณะบรรณาธิการ

นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงปิยดา อังศุวัชรากร	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ธนพล ยิสารคุณ	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นางสุมณี รัตนมรรคคา	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
นางสาวธนพร ธำรงลักษ์	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นางสาวปิยะภรณ์ โพธิ์คำ	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คำนำ

วัคซีนถือเป็นมาตรการสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสเชื้อโรคจากการปฏิบัติงานที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากกว่าประชากรทั่วไป

โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายเชื้อผ่านทางการสัมผัสเลือด และสารคัดหลั่งต่างๆ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ จากบุคลากรสู่ผู้ป่วยได้อีกด้วย

กรมควบคุมโรค จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแนวทางดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการดำเนินงาน การจัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย การประมาณความต้องการใช้วัคซีน การขอรับการสนับสนุนวัคซีน การกระจายวัคซีน การรายงานผลการให้บริการ การคำนวณความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากได้รับวัคซีน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนจะได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขของประเทศโดยรวม

สารบัญ

		หน้า
1.	ที่มาและความสำคัญ	1
2.	โรคไวรัสตับอักเสบบี และสถานการณ์ของโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	2
3.	กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายการดำเนินงาน	3
4.	วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี	5
5.	การดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงาน	6
6.	การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย	7
7.	การคาดประมาณการใช้วัคซีน และการขอรับการสนับสนุนวัคซีน	8
8.	การกระจายวัคซีน	9
9.	ขั้นตอนการให้บริการ	9
10.	การรายงานผลการให้บริการ	10
11.	การคำนวณความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกัน และผลงานการให้บริการ	10
12.	การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	11
	ภาคผนวก	
	■ คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 718/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	13
	■ แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	15
	■ แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	17

1. ที่มาและความสำคัญ

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (Healthcare Workers : HCWs) เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและดำเนินงานในระบบสาธารณสุข และถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย การปฏิบัติงานหรือหัตถการต่างๆ อาจส่งผลให้บุคลากรติดเชื้อจากผู้ป่วย รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย หากการปฏิบัติงานขาดความระมัดระวังหรือขาดการป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสม นอกจากนี้หากบุคลากรเจ็บป่วยและไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องหรือมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานขณะเจ็บป่วยไม่เหมาะสม บุคลากรอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่อตัวบุคลากรเอง ต่อผู้ป่วย และต่อโรงพยาบาลโดยรวม

กระทรวงสาธารณสุขเริ่มมีการให้วัคซีนที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อป้องกันการติดและแพร่กระจายเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งลดโอกาสการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่อาจส่งผลให้เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่และเกิดการระบาดใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติให้คำแนะนำการให้วัคซีนและกำหนดรายการวัคซีนที่จำเป็นต้องให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการทบทวนคำแนะนำและกำหนดรายการวัคซีนอีกครั้ง โดยดำเนินการแบ่งเป็นวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปตามกลุ่มอายุ วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ และวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงด้านอื่นๆ ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ซึ่งคำแนะนำรายการวัคซีนที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขควรได้รับ มีวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีรวมอยู่ด้วย โดยกำหนดให้จำนวน 3 เข็ม เว้นระยะห่าง 0, 1 และ 6 เดือน ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบลำดับความสำคัญของวัคซีนในผู้ใหญ่ ซึ่งมีวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นหนึ่งในวัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่ที่จะต้องนำเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยทันที ดังนั้น ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรคจึงจัดทำโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นต้นมา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ กรมควบคุมโรคจึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2570 สำหรับให้ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและความมั่นคงของระบบสาธารณสุขไทยในอนาคต

2. โรคไวรัสตับอักเสบบี และสถานการณ์ของโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

โรคไวรัสตับอักเสบบี เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เป็นไวรัสชนิด double-stranded enveloped DNA ใน Family Hepadnaviridae, Genus Orthohepadnavirus สายพันธุ์ที่ก่อโรคในคนมีคนเป็นแหล่งรังโรคเท่านั้น มักติดเชื้อและแบ่งตัวที่เซลล์ตับ ติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อหรือ ผู้ที่เป็นพาหะ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ ใช้ของมีคมร่วมกัน และติดต่อจากแม่สู่ลูก โรคไวรัสตับอักเสบบี มีระยะฟักตัวประมาณ 75 วัน การติดเชื้ออาจไม่มีอาการ หรือมีการแสดงอาการตับอักเสบ เช่น ไข้ อ่อนเพลีย ตัวเหลือง ตาเหลือง พบอาการแสดงในทารก ร้อยละ 1 ในเด็กอายุ 1-5 ปี ร้อยละ 10 และในผู้ที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ร้อยละ 30 โดยผู้ใหญ่มีโอกาสเกิดอาการรุนแรงมากกว่าเด็ก หลังการติดเชื้อเฉียบพลัน และอาจพัฒนาเป็นการติดเชื้อเรื้อรังได้ โดยพบในทารก ร้อยละ 80-90 ในเด็กอายุ 1-5 ปี ร้อยละ 30-50 และในผู้ที่อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป พบน้อยกว่าร้อยละ 5 ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรังมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับหรือโรคตับแข็ง ร้อยละ 20-40 ภายในระยะเวลาเฉลี่ย 30 ปี การวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบ บี ทำได้โดยการตรวจหา Hepatitis B surface antigen (HBsAg) และภูมิคุ้มกันต่อชิ้นส่วนอื่นของไวรัสตับอักเสบบี เพื่อประเมินระยะการติดเชื้อ การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาจำเพาะในระยะเฉียบพลัน ส่วนระยะเรื้อรังแนะนำให้รักษาด้วยยาต้านไวรัสตามข้อบ่งชี้ ทั้งนี้ วัคซีนจึงเป็นวิธีการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ปี พ.ศ. 2565 องค์การอนามัยโลกประมาณผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรังทั่วโลก จำนวน 254 ล้านคน โดยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 61 ล้านคน ข้อมูลจากการศึกษาในปี พ.ศ. 2567 ประมาณการว่าประเทศไทยมีพาหะไวรัสตับอักเสบบี ประมาณ 1.1 ล้านคน โดยไม่พบในผู้อายุน้อยกว่า 20 ปี พบในอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 0.30 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 1.20 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 2.06 อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 2.16 และอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.32 รวมเป็นทั้งหมดร้อยละ 1.68 ของประชากรไทย

สถานการณ์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2554 พบว่า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ร้อยละ 4.7 มีภูมิคุ้มกันจากทั้งการติดเชื้อในอดีตและการได้รับวัคซีน ร้อยละ 61.3 โดยในจำนวนนี้มีประวัติการได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ร้อยละ 31.7

3. กลุ่มเป้าหมาย และเป้าหมายการดำเนินงาน

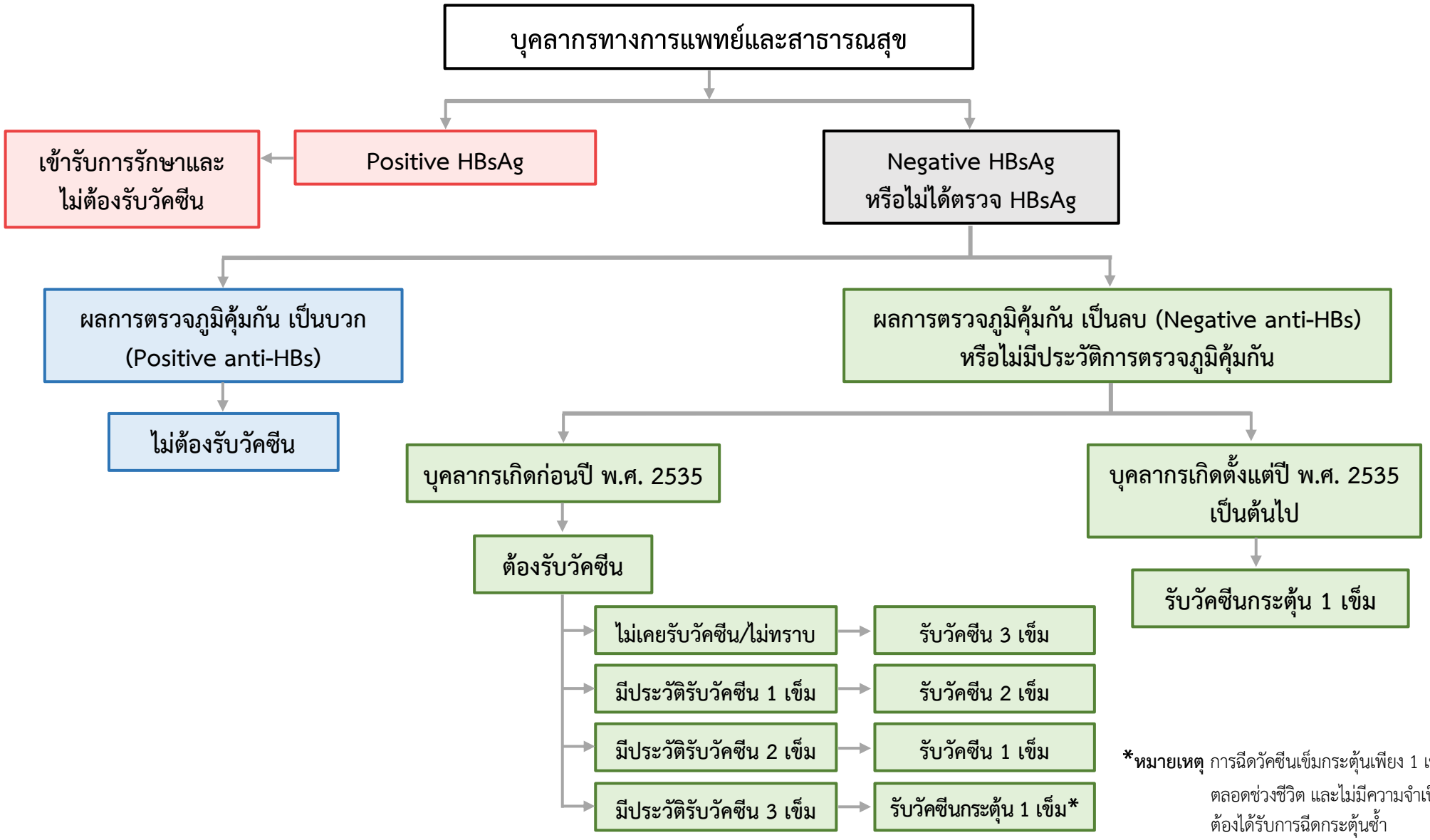
กลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีก่อนสัมผัสโรค (Pre-exposure prophylaxis) ได้แก่ บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือด คราบเลือด สารคัดหลั่ง เนื้อเยื่อผู้ป่วย หรือมีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากของมีคมบาดหรือถูกกัดจากผู้ป่วย ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ตรวจสิ่งส่งตรวจที่อาจปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบบี รวมถึงนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ได้บรรจุเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และมีอัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนถึงร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ. 2539 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าบุคลากรบางส่วนอาจมีประวัติการได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน จึงมีคำแนะนำให้พิจารณาการให้วัคซีนเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่กำหนด

กรมควบคุมโรค แนะนำให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขควรได้รับการตรวจเลือดเพื่อให้ทราบถึงการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ก่อนการพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี **โดยเฉพาะบุคลากรที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ควรได้รับการตรวจเลือดทุกราย (ซึ่งอยู่ในสิทธิประโยชน์การคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยการตรวจหา HBsAg ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)** จึงกำหนดแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามประวัติผลเลือดเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบี และประวัติการได้รับวัคซีน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1) **กลุ่มบุคลากรที่มีประวัติ HBsAg เป็นผลบวก:** เข้ารับการรักษาและไม่ต้องรับวัคซีน
2) **กลุ่มบุคลากรที่มีประวัติ HBsAg เป็นผลลบ หรือไม่มีประวัติการตรวจ HBsAg** แบ่งได้ดังนี้
   - 2.1) **กรณีมีผลการตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี เป็นบวก (Positive anti-HBs)**: ไม่ต้องรับวัคซีน
   - 2.2) **กรณีมีผลการตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี เป็นลบ (Negative anti-HBs) หรือไม่มีประวัติการตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี:**
     - **บุคลากรที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535**
       - ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติวัคซีน: รับวัคซีน 3 เข็ม ระยะห่าง 0 , 1 , 6 เดือน
       - มีประวัติเคยได้รับวัคซีน 1 เข็ม: รับวัคซีน 2 เข็ม
       - มีประวัติเคยได้รับวัคซีน 2 เข็ม: รับวัคซีน 1 เข็ม
       - มีประวัติได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น: รับวัคซีนกระตุ้น 1 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 3 และเข็มกระตุ้น ห่างกันอย่างน้อย 12 เดือน
       - มีประวัติได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม และเคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว: ไม่ต้องรับวัคซีน
     - **บุคลากรที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป**
       - ไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น: รับวัคซีนกระตุ้น 1 เข็ม
       - เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น: ไม่ต้องรับวัคซีน

โดยกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพียง 1 เข็ม ตลอดช่วงชีวิต และไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำทุกปี



รูปที่ 1 : แผนผังกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

เป้าหมายการดำเนินงาน

เพื่อป้องกันการติดเชื้อ การเจ็บป่วย และการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยกำหนดให้**ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ครบตามเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90**

4. วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

องค์ประกอบของวัคซีน :

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine) ในรูปแบบน้ำ ผลิตจากโปรตีนผิวของไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B surface antigen : HBsAg) โดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม Recombinant DNA vaccine ซึ่งเป็นการสอดแทรกยีนส์ที่ควบคุมการสร้าง HBsAg เข้าไปในเซลล์ เช่น เซลล์ยีสต์ หรือเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อให้เซลล์เหล่านี้ผลิต HBsAg แล้วนำมาทำให้บริสุทธิ์และประกอบเป็นวัคซีน ปัจจุบันวัคซีนที่ขึ้นทะเบียน กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 5 ตำรับ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2569) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ที่ขึ้นทะเบียนและจำหน่ายในประเทศไทย

ชื่อการค้า	บริษัทผู้รับอนุญาต	บริษัทผู้ผลิต	เลขทะเบียนตำรับยา	เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน*
HEPATITIS B VACCINE (rDNA) (ADULT)	บริษัท มาสุ จำกัด	Serum Institute of India Pvt. Ltd.	1C 215/50	Yeast-derived
ENGERIX-B	บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด	GlaxoSmithKline Biologicals SA.	1C 963/29	Yeast-derived
BEVAC	บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด	Biological E. Limited	1C 7/61 (B)	Yeast-derived
HEBERBIOVAC HB	บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด	Centro de Ingenieria Genetica Y Biotechnologia	1C 23/45	Yeast-derived
EUVAX B	บริษัท แอลจี เคม ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) จำกัด	LG CHEM, LTD.	1C 9/64 (B)	Yeast-derived

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา https://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/FRM_VACCINE_HUMAN.aspx

***หมายเหตุ** วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Recombinant DNA ของแต่ละบริษัท สามารถฉีดสลับทดแทนกันได้

5. การดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินงาน

การให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยบริการสามารถเริ่มสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ขอรับการสนับสนุนวัคซีน วางแผนการให้บริการ และการรายงานผลการให้บริการภายใต้การดำเนินงานคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ดังนี้

การดำเนินงานให้บริการวัคซีน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. **การสำรวจกลุ่มเป้าหมาย** **หน่วยบริการ** สำรวจจำนวนและรวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมายประจำปี 2570 เพื่อคาดประมาณการใช้วัคซีน	กันยายน - ตุลาคม 2569
2. **การขอรับการสนับสนุนวัคซีน** **หน่วยบริการ** แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรค ตามแบบฟอร์มของกรมควบคุมโรค	
3. **การกระจายวัคซีน** **กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป** จัดส่งวัคซีนให้หน่วยบริการ 1 รอบ โดยบริษัทขนส่งวัคซีน	มีนาคม - เมษายน 2570
4. **การวางแผนการให้บริการ** **หน่วยบริการ** วางแผนเพื่อเตรียมการให้บริการวัคซีน ขณะให้บริการ และหลังให้บริการ	มีนาคม - เมษายน 2570
5. **การรายงานผลการให้บริการ** **หน่วยบริการ** รายงานผลการให้บริการตามระยะเวลาที่กรมควบคุมโรคกำหนด	ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2570 สำหรับการให้บริการเข็มที่ 1 และ 2 ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2570 สำหรับการให้บริการเข็มที่ 3

6. การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย

ขอให้หน่วยบริการสำรวจข้อมูลรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตาม**แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (แบบฟอร์มที่ 1)** โดยเตรียมข้อมูล ดังต่อไปนี้

- ชื่อ - นามสกุล
- เพศ
- วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)
- ตำแหน่ง
- สถานที่ปฏิบัติงาน
- ประวัติการตรวจ HBsAg (HBsAg เป็นบวก / HBsAg เป็นลบ / ไม่ได้ตรวจ)
- ประวัติการตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody) จะแบ่งได้ดังนี้
  1) Positive anti-HBs
  2) Negative anti-HBs หรือไม่มีผลตรวจภูมิคุ้มกัน → พิจารณาที่ประวัติการได้รับวัคซีนเพิ่มเติม แบ่งได้ดังนี้
     - บุคลากรที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535
       - ไม่เคยได้รับวัคซีน/ไม่ทราบประวัติวัคซีน
       - มีประวัติรับวัคซีน 1 เข็ม
       - มีประวัติรับวัคซีน 2 เข็ม
       - มีประวัติรับวัคซีน 3 เข็ม แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น
       - มีประวัติรับวัคซีน 3 เข็ม และเคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว
     - บุคลากรที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป
       - ไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น
       - เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น

  โดยการแปลผลตรวจภูมิคุ้มกันกระทำโดยแพทย์ผู้ตรวจ เท่านั้น

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานดังต่อไปนี้

- **หน่วยบริการ** สำรวจรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามแบบฟอร์มที่ 1 และสรุปจำนวนความต้องการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีรายหน่วยบริการ ลงในแบบฟอร์มที่ 2 เพื่อรายงานผลการสำรวจไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ กรณีหน่วยบริการอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากอยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครขอให้รายงานผลการสำรวจไปยังสำนักอนามัย/สำนักการแพทย์ และหากอยู่นอกสังกัดกรุงเทพมหานครขอให้รายงานผลการสำรวจไปยังสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
- **สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร** สรุปจำนวนและรายงานจำนวนความต้องการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด ลงในแบบฟอร์มที่ 2 ส่งไปยังกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- **สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง** กำกับ และติดตามการสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีของจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสรุปจำนวนและรายงานจำนวนความต้องการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยงานตนเอง เพื่อรายงานผลการสำรวจไปยังกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ภายในระยะเวลาที่กำหนด

7. การคาดประมาณการใช้วัคซีน และการขอรับการสนับสนุนวัคซีน

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จะจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 1 รอบ การคำนวณจำนวนความต้องการวัคซีน แบ่งได้ดังนี้

1) **กลุ่มบุคลากรที่มีประวัติ HBsAg Positive:** ไม่ต้องเบิกวัคซีน
2) **กลุ่มบุคลากรที่มีประวัติ HBsAg Negative หรือไม่มีประวัติการตรวจ HBsAg** แบ่งได้ดังนี้
   - 2.1) **กรณีมีผลการตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี เป็นบวก (Positive anti-HBs):** ไม่ต้องเบิกวัคซีน
   - 2.2) **กรณีมีผลการตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี เป็นลบ (Negative anti-HBs) หรือไม่มีประวัติการตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี:**
     - ➢ **บุคลากรที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535**
       - ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติวัคซีน: เบิกวัคซีนจำนวน 3 โดส
       - มีประวัติได้รับวัคซีน 1 เข็ม: เบิกวัคซีนจำนวน 2 โดส
       - มีประวัติได้รับวัคซีน 2 เข็ม: เบิกวัคซีนจำนวน 1 โดส
       - มีประวัติได้รับวัคซีน 3 เข็ม แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น: เบิกวัคซีนจำนวน 1 โดส
       - มีประวัติได้รับวัคซีน 3 เข็ม และเคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว: ไม่ต้องเบิกวัคซีน
     - ➢ **บุคลากรที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป:**
       - ไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น: เบิกวัคซีนจำนวน 1 โดส
       - เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น: ไม่ต้องเบิกวัคซีน

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ที่นำมาให้แก่บุคลากร เป็นวัคซีนชนิด single dose (1 ml ต่อขวด) โดยจะคิดอัตราการสูญเสียวัคซีนร้อยละ 1 ซึ่งคิดเป็นตัวคูณการสูญเสียวัคซีน เท่ากับ 1.01

<u>การคำนวณความต้องการวัคซีน</u> คำนวณได้ดังนี้

จำนวนวัคซีนที่ต้องการของกลุ่มบุคลากรที่มีผลการตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี เป็นลบ (Negative anti-HBs) หรือไม่มีประวัติการตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี กรณีเกิดก่อนปี พ.ศ. 2535

= [(จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติวัคซีน x 3)
+ (จำนวนบุคลากรที่มีประวัติได้รับวัคซีน 1 เข็ม x 2)
+ (จำนวนบุคลากรที่มีประวัติได้รับวัคซีน 2 เข็ม)
+ (จำนวนบุคลากรที่มีประวัติได้รับวัคซีน 3 เข็ม แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น)
+ จำนวนวัคซีนที่ต้องการของกลุ่มบุคลากรที่มีผลการตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี เป็นลบ (Negative anti-HBs) หรือไม่มีประวัติการตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี กรณีเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น]

ดังนั้น **จำนวนวัคซีนที่ต้องการทั้งหมด** = (จำนวนวัคซีนที่ต้องการ x 1.01)

การขอรับการสนับสนุนวัคซีน

ขอให้หน่วยบริการ/ผู้รับผิดชอบแจ้งยืนยันจำนวนความต้องการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ผ่านทาง**แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข** ที่กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดทำขึ้น

โดยกรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ตามจำนวนความต้องการวัคซีน ทั้งนี้ จำนวนการจัดสรรวัคซีนอาจปรับตามจำนวนวัคซีนที่จัดหาได้ ณ ขณะนั้น

8. การกระจายวัคซีน

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป จะกระจายวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้หน่วยบริการ โดยบริษัทจัดส่งวัคซีน ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากกองโรคติดต่อทั่วไป อนุมัติการเบิกวัคซีน ซึ่งกำหนดการจัดส่งวัคซีน 1 รอบ โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดต่อไป

9. ขั้นตอนการให้บริการ

การให้บริการ

- หน่วยบริการตรวจสอบความพร้อมก่อนให้บริการ ได้แก่ ควรจัดเตรียมวัคซีน อุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีน ระบบลูกโซ่ความเย็น และอุปกรณ์กู้ชีพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- ก่อนการให้บริการ ควรซักประวัติการได้รับวัคซีน ประวัติการเจ็บป่วย และประเมินสุขภาพ/ภาวะการเจ็บป่วย ของผู้รับบริการก่อนการรับบริการ
- ผู้ให้บริการวัคซีนควรแจ้งให้ผู้รับบริการทราบข้อมูล ประโยชน์ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการวัคซีนสามารถตัดสินใจเข้ารับวัคซีนได้โดยสมัครใจ
- หลังฉีดวัคซีนให้สังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที เพื่อเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันภายภายใน 30 นาทีภายหลังได้รับสารก่อกระตุ้นการแพ้ หากพบผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงระหว่างการสังเกตอาการให้รีบดำเนินการรักษาตามแนวทางและพิจารณาส่งต่อหากเกินศักยภาพของหน่วยบริการ

การดำเนินงานหลังการให้บริการ

- การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI surveillance) ตามแนวทางของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
- ขวดวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีนให้ทำลายแบบขยะติดเชื้อตามระบบปกติที่หน่วยงานดำเนินการอยู่

10. การรายงานผลการให้บริการ

ภายหลังการให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานดังต่อไปนี้

- **หน่วยบริการ** รวบรวมข้อมูลผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นรายบุคคล (แบบฟอร์มที่ 3) และสรุปข้อมูลผลการให้บริการ (แบบฟอร์มที่ 4) รายละเอียดตามแบบฟอร์มในภาคผนวก โดยส่งข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ กรณีหน่วยบริการอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากอยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครขอให้ส่งข้อมูลไปยังสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ และหากอยู่นอกสังกัดกรุงเทพมหานครขอให้ส่งข้อมูลไปยังสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
- **สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร** รวบรวมข้อมูลผลการให้บริการวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เป็นรายบุคคล (แบบฟอร์มที่ 3) และสรุปข้อมูลผลการให้บริการ (แบบฟอร์มที่ 4) รายละเอียดตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ของหน่วยบริการ/สถานบริการภาครัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูลหน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ กรณีหน่วยบริการอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย/สำนักการแพทย์/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวบรวมข้อมูลจากหน่วยบริการที่อยู่ในสังกัด พร้อมทั้งรายงานผลการให้บริการ ไปยังกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- **สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง** กำกับ ติดตามการรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ของจังหวัดในเขตที่รับผิดชอบ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขให้ครบถ้วน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลผลการให้บริการวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เป็นรายบุคคล (แบบฟอร์มที่ 3) และสรุปข้อมูลผลการให้บริการ (แบบฟอร์มที่ 4) รายละเอียดตามแบบฟอร์ม

ในภาคผนวก ของหน่วยงานตนเอง เพื่อรายงานผลไปยังกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ภายในระยะเวลาที่กำหนด **ทั้งนี้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง** ต้องดำเนินการกำกับ ติดตาม พร้อมทั้งรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ของหน่วยบริการที่อยู่นอกสังกัดกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน

11. การคำนวณความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกัน และผลงานการให้บริการ

11.1 การคำนวณความครอบคลุมการได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกัน จำเป็นต้องทำการสำรวจจำนวนเข็มวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ที่ได้รับทั้งหมดของบุคลากรแต่ละรายหลังดำเนินการให้วัคซีนและพิจารณาการได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันบุคลากรโดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณา	ผลการพิจารณา
ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม หรือ ได้รับวัคซีน 1 เข็ม (กรณีเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น) หรือ มีประวัติมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี	ผ่านเกณฑ์
ไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับวัคซีน 1 เข็ม หรือ 2 เข็ม	ไม่ผ่านเกณฑ์

วิธีการคำนวณความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี และการมีภูมิคุ้มกันในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรายสถานบริการ สามารถคำนวณได้จากสูตร

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกัน

$$= \frac{\text{จำนวนบุคลากรที่ได้รับวัคซีนผ่านเกณฑ์ x 100}}{\text{จำนวนบุคลากรที่สำรวจทั้งหมด - จำนวนบุคลากรที่มีผล HBsAg positive}}$$

11.2 ผลงานการให้บริการวัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง ร้อยละของวัคซีนที่ให้บริการแก่บุคลากรจากจำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร

วิธีการคำนวณผลงานให้บริการวัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรายสถานบริการ สามารถคำนวณได้จากสูตร

$$\textbf{ผลงานการให้บริการวัคซีน} = \frac{\text{จำนวนวัคซีนที่ให้บริการแก่บุคลากร x 100}}{\text{จำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร}}$$

12. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ก่อนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยบริการควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการช่วยชีวิตเบื้องต้นและปฏิบัติตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ Adrenaline ชุดอุปกรณ์สำหรับให้สารน้ำ (IV fluid set) และสารน้ำ (IV fluid for resuscitation, Normal saline หรือ Ringer's lactated solution) ถุงบีบลมเพื่อช่วยหายใจพร้อมชุดหน้ากาก (Ambu bag and Oxygen face mask) รวมทั้งจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการภายหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง เมื่อให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย ควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการภายหลังที่ได้รับวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นได้ และหลังจากให้วัคซีนแล้วจะต้องสังเกตอาการภายหลังจากการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูง อาการไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนมักไม่รุนแรง แต่ต้องตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือมีผลต่อการยอมรับวัคซีนของบุคลากร ดังนั้น นอกเหนือจากการเตรียมการเพื่อกู้ชีพเบื้องต้น ณ หน่วยบริการและการส่งต่อผู้ป่วยแล้ว หน่วยบริการยังต้องดำเนินการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายใน 30 วัน ตามนิยามของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค หากพบผู้ป่วยที่มีอาการให้ดำเนินการรายงานและสอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนดต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 : คำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 718/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข



คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ ๗๑๘ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB)
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและดำเนินงานในระบบสาธารณสุข การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB) ทำให้เกิดอาการของตับอักเสบ ตับอักเสบเรื้อรัง จนนำไปสู่ตับแข็งและมะเร็งตับตามมา นอกจากนี้โรคไวรัสตับอักเสบบี (HB) สามารถส่งต่อเชื้อโรคไปสู่ผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน และครอบครัวได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงแนะนำและกำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB) เป็นวัคซีนที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขควรได้รับ

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB) อย่างเหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมควบคุมโรค จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑	อธิบดีกรมควบคุมโรค	ที่ปรึกษา
๑.๒	ศาสตราจารย์ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ที่ปรึกษา
๑.๓	นายวีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค	ประธานคณะทำงาน
๑.๔	ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค	รองประธานคณะทำงาน
๑.๕	นายชนินันท์ สนธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายไทย ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข	คณะทำงาน
๑.๖	นายฐิติพงษ์ ยิ่งยง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค	คณะทำงาน
๑.๗	นายชาตรี จุลเพชร นายแพทย์ชำนาญการ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค	คณะทำงาน

๑.๘ นางสาวศุภรัตน์...

๑.๘ นางสาวศุภรัตน์ เข็มนาค คณะทำงาน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

๑.๙ นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ คณะทำงาน
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

๑.๑๐ นายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ คณะทำงาน
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย ๑ คน

๑.๑๑ นางปิยดา อังศุวัชรากร คณะทำงาน
นายแพทย์ชำนาญการ และเลขานุการ
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

๑.๑๒ นางสาวปิยะภรณ์ โพธิ์คำ คณะทำงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และผู้ช่วยเลขานุการ
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

๑.๑๓ นางสาวธนพร ธำรงลักษ์ คณะทำงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และผู้ช่วยเลขานุการ
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ จัดทำกรอบการดำเนินงานและแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB)

๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดิเรก ขำแป้น)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

แบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

เขตสุขภาพที่ ..... **: จังหวัด**.....

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	วัน/เดือน/ ปี พ.ศ. เกิด	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	ประวัติตรวจ HBsAg			ประวัติการตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody)								
						HBsAg negative	HBsAg positive	ไม่ได้ตรวจ	Antibody Positive	Antibody Negative หรือไม่มีผลตรวจภูมิคุ้มกัน							
										เกิดก่อน พ.ศ. 2535					เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป	
										ไม่เคยได้รับวัคซีน / ไม่ทราบประวัติวัคซีน	เคยได้รับวัคซีน 1 เข็ม	เคยได้รับวัคซีน 2 เข็ม	เคยได้รับวัคซีน 3 เข็ม แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น	เคยได้รับวัคซีน 3 เข็ม และเคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว	ไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น	เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น
รวม																

หมายเหตุ : เป็นแบบฟอร์มตัวอย่างการสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่แต่ละหน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้สรุปจำนวนและรายงานจำนวนความต้องการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด

แบบฟอร์มที่ 2 : แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เขตสุขภาพ	จังหวัด	หน่วยบริการ	จำนวน HCW ทั้งหมด		จำนวน HCW ที่มีประวัติ HBsAg positive (คน)	จำนวน HCW ที่มีประวัติการตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody)								รวมจำนวนความต้องการวัคซีน HB (โดส)	สถานที่จัดส่งวัคซีน	ผู้ประสานงาน (จุดจัดส่งวัคซีน)	เบอร์โทรศัพท์
			จำนวน HCW เกิดก่อน พ.ศ. 2535 (คน)	จำนวน HCW เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป (คน)		Antibody Positive (คน)	Antibody Negative หรือไม่มีผลตรวจภูมิคุ้มกัน (คน)										
							เกิดก่อน พ.ศ. 2535					เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป					
							ไม่เคยได้รับวัคซีน / ไม่ทราบประวัติวัคซีน (คน)	เคยได้รับวัคซีน 1 เข็ม (คน)	เคยได้รับวัคซีน 2 เข็ม (คน)	เคยได้รับวัคซีน 3 เข็ม แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (คน)	เคยได้รับวัคซีน 3 เข็ม และเคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว (คน)	ไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (คน)	เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (คน)			
รวม																	

หมายเหตุ :

1. HCW หมายถึง Healthcare Worker บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ไม่รวมนักศึกษาแพทย์)
2. หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยบริการที่รับผิดชอบพื้นที่ระดับอำเภอขึ้นไป ได้แก่ รพศ. รพท. รพช. หรือเทียบเท่า โดยให้ รพ. แม่ข่ายรวบรวมข้อมูลของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่
3. กรณีจังหวัดมีพื้นที่รับผิดชอบหลายอำเภอ และมีพื้นที่ห่างไกลจากจุดส่งวัคซีน
   ติดต่อผู้ประสาน นางสาวปิยะภรณ์ โพธิ์คำ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร. 0 2590 3196 - 7

แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

แบบฟอร์มที่ 3 : แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

เขตสุขภาพที่ ..... **: จังหวัด**.....

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ	วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	วันที่ได้รับบริการ	เข็มที่ได้รับ	หมายเหตุ

หมายเหตุ : เป็นแบบฟอร์มตัวอย่างการบันทึกข้อมูลรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ที่แต่ละหน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

แบบฟอร์มที่ 4 : แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เขตสุขภาพ	จังหวัด	หน่วยบริการ	ผลงานการให้บริการ			ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน						หมายเหตุ
			จำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร (โดส)	จำนวนวัคซีนที่ให้บริการแก่บุคลากร (โดส)	ผลงานการให้บริการวัคซีน (ร้อยละ)	จำนวนบุคลากรทั้งหมดที่สำรวจ (คน)	จำนวนบุคลากรที่มีผล HBsAg positive (คน)	จำนวนบุคลากรที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม (คน)	จำนวนบุคลากรที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (คน)	จำนวนบุคลากรที่มีประวัติผลเลือดมีภูมิคุ้มกัน (คน)	ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน (ร้อยละ)	

หมายเหตุ :

1. หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยบริการที่รับผิดชอบพื้นที่ระดับอำเภอขึ้นไป ได้แก่ รพศ. รพท. รพช. หรือเทียบเท่า โดยให้ รพ. แม่ข่ายรวบรวมข้อมูลของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่
2. ผลงานการให้บริการวัคซีน หมายถึง ร้อยละของวัคซีนที่ให้บริการแก่บุคลากรจากจำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร



กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 - 5903196 - 7

